姓名：王建华（虚构）　男　56岁　科室：消化内科　病案号：SIM-ASC-20260901

住院病案复印件 · 专家审核版

病例主题

乙肝肝硬化失代偿期腹水加重，合并自发性细菌性腹膜炎及急性肾损伤，经抗感染、容量管理及腹水治疗后好转出院。

项目	资料
姓名 / 性别 / 年龄	王建华（虚构） / 男 / 56岁
科室 / 床号	消化内科（肝病病区） / 模拟12床
病案号	SIM-ASC-20260901
入院 / 出院	2026-09-01 09:20 / 2026-09-09 10:00
住院时长	8天（跨9个自然日期）
资料版本	v1.1 / 2026-09-15 / 待临床专家审核
用途	高年级住院医师临床思维训练及临床专家审核

文书属性

本册所有身份、病情、检验数值、微生物结果和操作经过均为教学合成，不来自真实患者。本册为完整答案病案，包含最终诊断，不应在考试接诊阶段整册发给学员。

图像与签署

超声图为AI合成示意，心电图为算法绘制示意；文字报告是病例设定，图像不能验证测量值，不能作为真实影像判读考试金标准。无真实医院标志或印章；页尾为虚构医师手写式模拟签名。

资料组成

病案首页、入院记录、首程与逐日病程、检验和检查报告、腹腔穿刺及治疗性放腹水记录、医嘱执行摘要、护理监测、出院记录。教学目标、分阶段披露及审核表另册提供。

姓名：王建华（虚构）　男　56岁　科室：消化内科　病案号：SIM-ASC-20260901

住院病案首页

登记项目	登记内容
姓名	王建华（虚构）
出生日期 / 年龄	1970-04-18 / 56岁
性别 / 民族 / 婚姻	男 / 汉族 / 已婚
职业 / 籍贯	仓储管理员 / 四川成都
现住址	四川省成都市武侯区锦和路36号锦和苑3栋502室
联系人 / 病史提供者	妻子（角色家属A） / 患者本人，妻子补充，基本可靠
入院途径	消化内科门诊转住院
入院诊断	乙肝肝硬化失代偿期，腹水加重；腹腔感染待排；肾功能异常待查
主要出院诊断	乙肝肝硬化失代偿期伴腹水
其他出院诊断	自发性细菌性腹膜炎（大肠埃希菌）；急性肾损伤1期（已恢复）；低钠血症（改善）；门静脉高压、脾大伴血小板减少；低白蛋白血症
诊疗操作	09-01诊断性腹腔穿刺；09-03复查穿刺；09-04治疗性放腹水6000 mL
手术 / 输血	未行外科手术、TIPS或肝移植；未输注红细胞、血浆或血小板。使用人血白蛋白另见医嘱。
药物过敏 / 转归	否认已知药物过敏 / 好转出院

诊断编码、费用、真实证件号及签章未编造。本页为教学病案首页样式，不是行政报送首页。

姓名：王建华（虚构）　男　56岁　科室：消化内科　病案号：SIM-ASC-20260901

入院记录（一）· 主诉与现病史

记录时间：2026-09-01 10:00

主诉

反复腹胀6个月，加重伴下肢水肿10天、尿量减少2天。

现病史

患者20年前体检发现乙肝表面抗原阳性，3年前经肝脏影像及血液检查诊断乙肝肝硬化。6个月前首次出现腹胀、双下肢水肿，在门诊接受抗病毒及口服利尿治疗后减轻，未住院，未行腹腔穿刺。近月腹围基本稳定，8月20日体重68 kg，肌酐78 μmol/L。

10天前聚餐及较多进食腌制食品后腹胀逐渐加重，裤腰变紧、早饱，双踝水肿延至小腿。8月28日至30日自行将呋塞米从20 mg/d加至40 mg/d，螺内酯仍为50 mg/d，腹胀无明显缓解。近3天摄食约平日一半，饮水约1000 mL/d；近2天估计尿量由约1500 mL/d降至800-1000 mL/d，尿色深，活动后乏力加重。

无寒战，自测体温最高37.4℃；仅有轻微弥漫腹部隐痛，无持续局限性剧痛。无呕吐、腹泻、呕血及黑便，最近大便黄褐色、每日1次。无咳嗽、咳痰、尿痛；无昼夜颠倒、行为异常或意识模糊。夜间可平卧，无胸痛及端坐呼吸。今门诊查见明显腹水及血压偏低，收入院。

近期用药与暴露

规律服用恩替卡韦1 mg/d（既往已失代偿）、螺内酯50 mg/d、呋塞米20 mg/d；入院当日尚未服利尿剂。否认近期NSAIDs、中草药、造影剂及其他肾毒性药物。近3个月未住院、未用抗菌药，无已知耐药菌定植史。

起病后精神稍差、睡眠受腹胀影响，食欲下降。近期增重主要考虑液体潴留，不能据体重增加排除营养风险。

消化内科 · 记录：赵衡　审核：沈妍



虚构医师手写式模拟签名 · 教学用

姓名：王建华（虚构）　男　56岁　科室：消化内科　病案号：SIM-ASC-20260901

入院记录（二）· 既往及个人家族史

肝病史

乙肝病程约20年；早期随访不规律。6个月前发生腹水后开始恩替卡韦1 mg每日一次空腹服用，否认漏服及拉米夫定等既往核苷类用药史。无既往SBP、肝性脑病、消化道出血、肝癌或门静脉血栓。

既往检查

2026-06-15门诊胃镜摘要：食管下段小静脉曲张，无红色征，无活动性出血；轻度门静脉高压性胃病。因门诊收缩压多在95-100 mmHg、偶有头晕，尚未启动非选择性β受体阻滞剂，拟肝病专科复评。2026-08-20肌酐78 μmol/L，钠135 mmol/L、钾4.2 mmol/L；当时无明显水肿，体重68 kg。上述为既往资料摘要，未另伪造胃镜原图。

其他既往史

否认高血压、糖尿病、冠心病、心衰、慢性肾病、结核病及恶性肿瘤史。无手术、外伤及输血史。疫苗接种细节不详。否认已知食物及药物过敏。

个人史

出生及长期居住四川成都，已婚，与妻子同住，育有一子。既往吸烟约10包年，5年前戒烟。饮酒量少，确诊肝硬化后已戒酒。无静脉药物使用、纹身及近期疫水接触。工作以站立和轻体力搬运为主。

家族史

母亲乙肝表面抗原阳性，未获知肝癌史；父亲有高血压。无已知遗传性肝病、肾病。

系统回顾

无近期明显消瘦或盗汗；无胸闷心悸、下肢单侧肿痛；无少量多次排尿、血尿或泡沫尿；无皮疹、关节肿痛；无视力异常或局灶性神经症状。

记录医师：赵衡（教学模拟签署）

消化内科 • 记录：赵衡　审核：沈妍



虚构医师手写式模拟签名 • 教学用

姓名：王建华（虚构）　男　56岁　科室：消化内科　病案号：SIM-ASC-20260901

入院记录（三）· 体格检查

项目	结果
生命体征	T 37.3℃；P 96次/min；R 20次/min；BP 98/62 mmHg；SpO2 97%（空气）
身高 / 体重 / 腹围	170 cm / 76.0 kg / 106 cm；近期无水肿时体重68 kg作为估计干重
一般情况	神志清，定向力完整，慢性肝病面容；轻度巩膜黄染，肝掌及上胸部蜘蛛痣
营养与皮肤	颞部及上臂肌肉较薄；皮肤完整，无活动性瘀斑或感染灶
头颈部	无颈静脉怒张，浅表淋巴结未触及肿大
心肺	心率96次/min，律齐，未闻及明显杂音；双肺呼吸音清，无湿啰音
腹部视触诊	腹部膨隆，腹壁稍紧，脐部平；轻度弥漫压痛，无反跳痛及肌紧张；肝脏肋下未触及，脾肋下约2 cm
腹部叩听诊	移动性浊音阳性、液波震颤阳性；肠鸣音4次/min；无明显血管杂音
泌尿及四肢	肾区无叩痛，双小腿对称凹陷性水肿2+，肢端温暖
神经系统	扑翼样震颤阴性，无病理反射，无局灶性体征

入院初步判断

存在肝硬化失代偿表现及明显腹水。虽无高热，但轻腹痛、尿量减少和血压偏低，需优先评估腹腔感染及循环灌注；不能仅按“低蛋白性水肿”处理。

消化内科 • 记录：赵衡　审核：沈妍



虚构医师手写式模拟签名 • 教学用

姓名：王建华（虚构）　男　56岁　科室：消化内科　病案号：SIM-ASC-20260901

首次病程记录

记录时间：2026-09-01 10:20（此时腹水结果尚未回报）

病例特点

56岁男性，乙肝肝硬化伴既往腹水，10天腹胀和水肿加重、2天尿量减少。近期高盐饮食、自增利尿剂及摄食减少。体检有腹水、轻腹痛、低正常血压，无腹膜刺激征及意识障碍。

初步诊断及依据

1.乙肝肝硬化失代偿期伴腹水加重：既往肝硬化、腹水史及本次体征支持。2.腹腔感染待排：缺乏发热不能排除SBP。3.肾功能异常待查：需与既往基线及尿量比较。

鉴别诊断

腹水原因包括门静脉高压性、心源性、恶性及结核性腹水；先行SAAG和腹水蛋白评估，再按线索选择进一步检查。少尿需鉴别摄入不足/利尿剂相关低灌注、感染相关肾损伤、HRS-AKI、肾实质损伤及梗阻。持续局限性腹痛或多菌培养需警惕继发性腹膜炎。

诊疗计划

暂停螺内酯及呋塞米；记录血压、尿量、体重和液体出入。急查血常规、肝肾功能、电解质、凝血、CRP、乳酸、尿常规/沉渣及血培养。尽早行超声评估和诊断性腹腔穿刺，送细胞分类、白蛋白、总蛋白、葡萄糖、LDH及培养；腹水床旁接种需在抗菌药前完成。

评估腹膜刺激征、血流动力学及呼吸情况。待腹水快速结果后立即决定抗菌治疗，不等待培养终报。以临床容量状态决定白蛋白及液体策略；不因腹水多而忽视循环灌注，也不盲目大量输液。继续抗病毒，结合肾功能复核剂量。向患者及家属说明诊断与穿刺目的。

上级审核：沈妍；记录：赵衡（均教学模拟签署）

消化内科 • 记录：赵衡　审核：沈妍



虚构医师手写式模拟签名 • 教学用

姓名：王建华（虚构）　男　56岁　科室：消化内科　病案号：SIM-ASC-20260901

血常规检验报告单

报告号：ASC-L01 标本：EDTA抗凝全血

采集时间：09-01 09:45 报告时间：09-01 10:15

检验项目	结果	提示	单位	参考区间 / 判读界值
白细胞	7.8		10^9/L	3.5-9.5
中性粒细胞比例	78	↑	%	40-75
中性粒细胞计数	6.08		10^9/L	1.8-6.3
淋巴细胞比例	13	↓	%	20-50
淋巴细胞计数	1.01	↓	10^9/L	1.1-3.2
单核细胞比例	7		%	3-10
嗜酸性粒细胞比例	1.5		%	0.4-8
嗜碱性粒细胞比例	0.5		%	0-1
红细胞	3.65	↓	10^12/L	4.3-5.8
血红蛋白	118	↓	g/L	130-175
红细胞比容	0.35	↓	L/L	0.4-0.5
平均红细胞体积	95.9		fL	82-100
平均红细胞血红蛋白量	32.3		pg	27-34
平均红细胞血红蛋白浓度	337		g/L	316-354
血小板	68	↓	10^9/L	125-350

检验方法：模拟实验室常规方法

参考区间为本模拟实验室设定；↑高于参考上限，↓低于参考下限。无统一参考区间的项目仅报告结果，不强行标箭头。

检验者：林砚　审核者：苏禾（角色标识，教学模拟签署）

检验科 • 记录：林砚　审核：苏禾



虚构医师手写式模拟签名 • 教学用

姓名：王建华（虚构）　男　56岁　科室：消化内科　病案号：SIM-ASC-20260901

肝肾功能及电解质检验报告单

报告号：ASC-L02 标本：血清

采集时间：09-01 09:45 报告时间：09-01 10:40

检验项目	结果	提示	单位	参考区间 / 判读界值
ALT	38		U/L	9-50
AST	56	↑	U/L	15-40
总胆红素	48	↑	μmol/L	0-21
直接胆红素	26	↑	μmol/L	0-7
白蛋白	25	↓	g/L	40-55
总蛋白	61	↓	g/L	65-85
ALP	112		U/L	45-125
GGT	78	↑	U/L	10-60
尿素	10.2	↑	mmol/L	3.1-8.0
肌酐	118	↑	μmol/L	57-97
钠	129	↓	mmol/L	135-145
钾	4.6		mmol/L	3.5-5.3
氯	97	↓	mmol/L	99-110
总二氧化碳	22		mmol/L	22-29
葡萄糖	5.8		mmol/L	3.9-6.1
LDH	180		U/L	120-250

检验方法：模拟实验室常规方法

本次血清白蛋白在白蛋白输注前采集，与同日腹水白蛋白配对。既往肌酐78 μmol/L（08-20）；肌酐动态升高需结合时间窗判定AKI。

检验者：林砚 审核者：苏禾（角色标识，教学模拟签署）

检验科 • 记录：林砚　审核：苏禾



虚构医师手写式模拟签名 • 教学用

姓名：王建华（虚构）　男　56岁　科室：消化内科　病案号：SIM-ASC-20260901

凝血及炎症指标检验报告单

报告号：ASC-L03 标本：枸橼酸抗凝血浆 / 血清 / 静脉全血

采集时间：09-01 09:45 报告时间：09-01 10:45

检验项目	结果	提示	单位	参考区间 / 判读界值
凝血酶原时间	17.8	↑	s	11-14.5
INR	1.55	↑		0.8-1.2
APTT	38	↑	s	25-35
纤维蛋白原	1.8	↓	g/L	2-4
CRP	42	↑	mg/L	0-8
降钙素原	0.32	↑	ng/mL	0-0.05
静脉乳酸	1.8		mmol/L	0.5-2.2

检验方法：模拟实验室常规方法

炎症标志物不能替代腹水细胞计数。INR反映凝血检验结果，不单独用于预测肝硬化患者低风险穿刺的出血风险。

检验者：林砚 审核者：苏禾（角色标识，教学模拟签署）

检验科 • 记录：林砚　审核：苏禾

林砚　苏禾

虚构医师手写式模拟签名 • 教学用

姓名：王建华（虚构）　男　56岁　科室：消化内科　病案号：SIM-ASC-20260901

尿液与病因筛查报告单

报告号：ASC-L04 标本：清洁中段尿 / 血清

采集时间：09-01 10:00 / 09:45 报告时间：09-01 11:20 / 09-02 09:00

检验项目	结果	提示	单位	参考区间 / 判读界值
尿比重	1.02			1.005-1.03
尿蛋白	阴性			阴性
尿隐血	阴性			阴性
尿红细胞	1		个/HPF	0-3
尿白细胞	2		个/HPF	0-5
颗粒管型	未见			未见
尿蛋白/肌酐比	0.09		g/g	0-0.15
HBsAg	阳性			阴性
HBeAg	阴性			阴性
抗-HBe	阳性			按感染状态解释
抗-HBc	阳性			按感染状态解释
HBV DNA	<20		IU/mL	低于定量下限20
抗-HCV	阴性			阴性
HIV抗原/抗体	阴性			阴性
AFP	4.2		ng/mL	0-7

检验方法：模拟实验室常规方法

尿常规当日回报；HBV DNA及血清学次日回报。定性阳性直接以文字提示，不使用数值上下箭头。AFP正常不能排除肝癌。

检验者：林砚 审核者：苏禾（角色标识，教学模拟签署）

检验科 • 记录：林砚　审核：苏禾



虚构医师手写式模拟签名 • 教学用

姓名：王建华（虚构）　男　56岁　科室：消化内科　病案号：SIM-ASC-20260901

超声检查报告单

报告号：ASC-US01 检查：2026-09-01 10:35 报告：11:00

检查项目

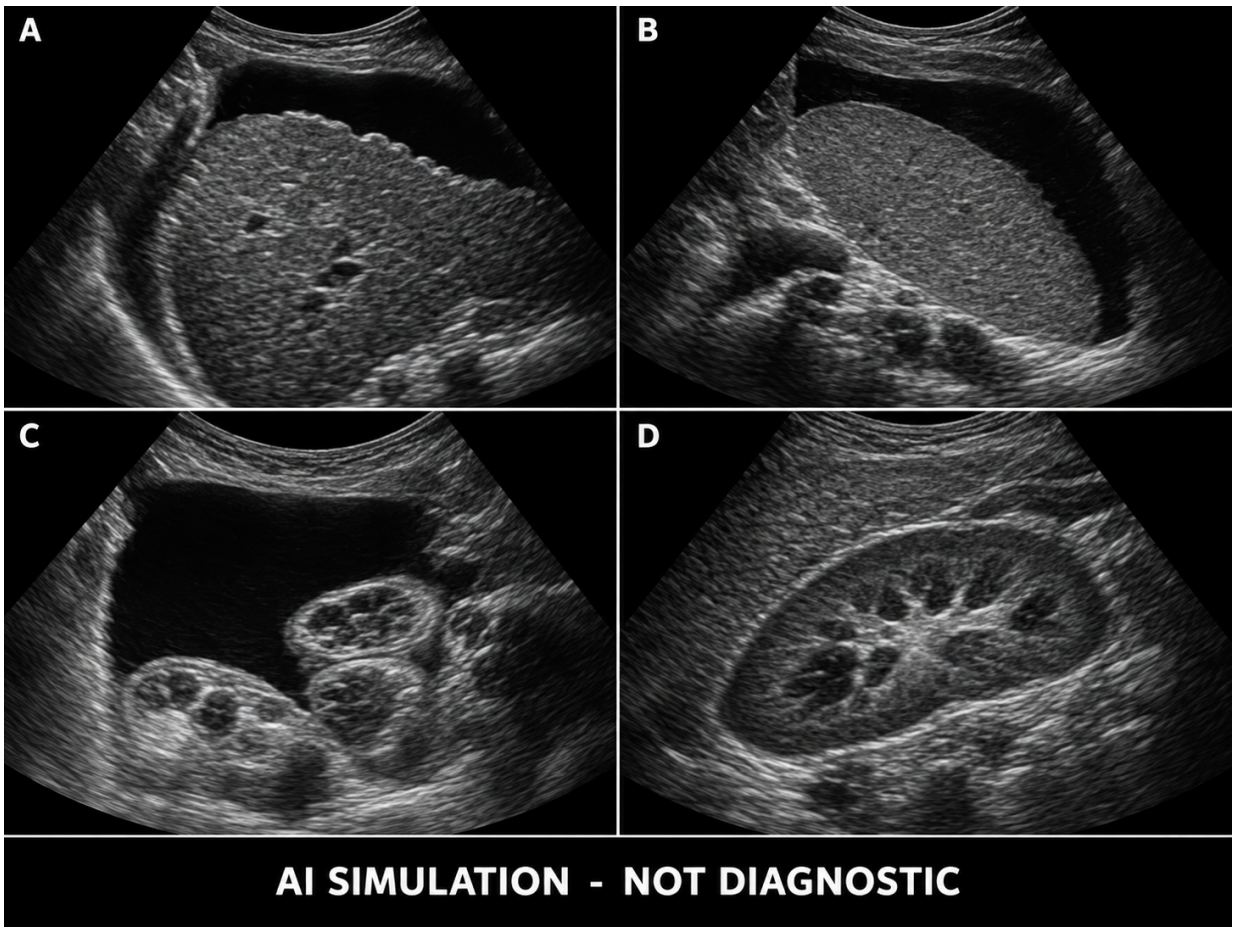
肝胆脾、门静脉及腹水定位；双肾与膀胱。

文字所见（合成病例设定）

肝包膜欠光整，实质回声增粗、分布不均，未见明确局灶性占位。门静脉主干内径约14 mm，彩色血流示向肝血流，未见明确充盈缺损。脾长径约145 mm、厚约48 mm。腹盆腔多处液性暗区，肝周、脾周及双侧髂窝可见，左下腹可选择安全穿刺窗。胆管无明显扩张。双肾大小形态尚可，集合系统未见扩张，膀胱无明显潴留。

超声提示

肝硬化声像改变；脾大；大量腹水；本次未见明确门静脉血栓、肝内占位或尿路梗阻征象。



A 肝周；B 脾周；C 下腹液体区；D 右肾。AI合成示意，无真实采集及测量，不用于独立诊断。

图像未包含彩色多普勒，门静脉血流等结论仅为文字设定，不能从本图验证。检查/审核：许澄 / 周岚（教学模拟签署）。

超声科 • 记录：许澄　审核：周岚

许澄　周岚

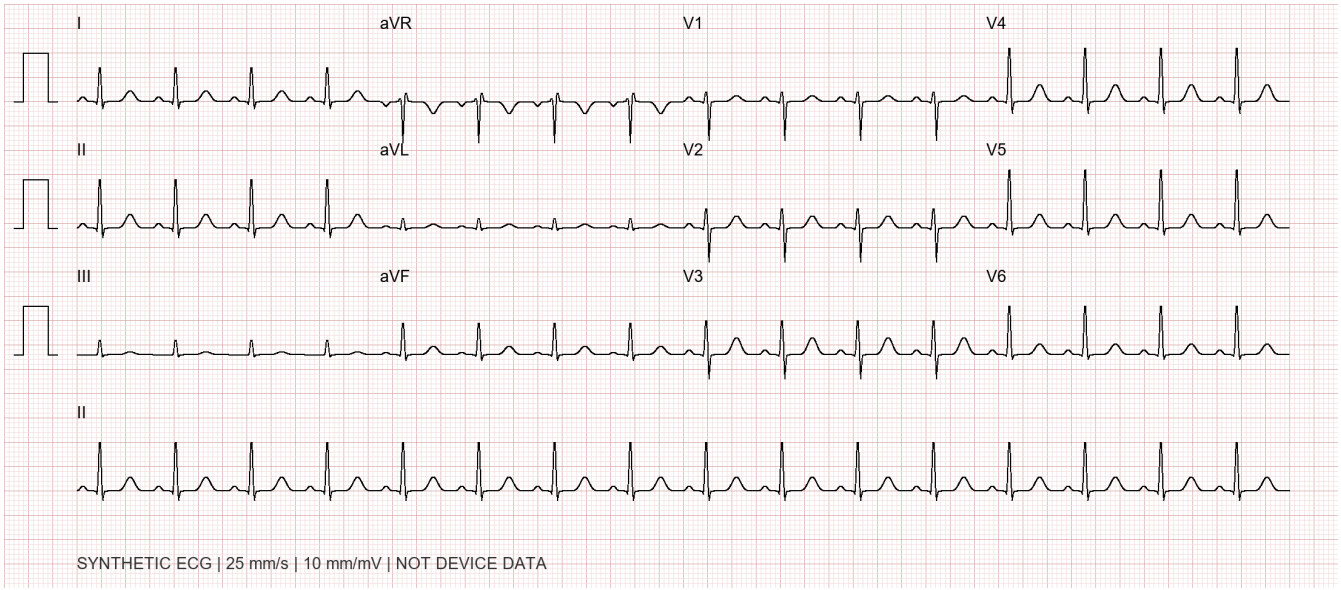
虚构医师手写式模拟签名 • 教学用

姓名：王建华（虚构）　男　56岁　科室：消化内科　病案号：SIM-ASC-20260901

心电图检查报告单

报告号：ASC-ECG01　检查：2026-09-01 10:10　报告：10:20

参数	结果
心率 / 节律	96次/min / 窦性心律
PR / QRS	160 ms / 86 ms
QT / QTc（Bazett）	342 ms / 433 ms
电轴 / ST-T	约+45°；无急性缺血性ST-T改变（病例设定）



算法绘制的12导联示意，25 mm/s、10 mm/mV；非采集信号，间期及电轴以文字设定为准，不作为测量题。

结论：窦性心律，未见明显急性异常。本例无急性胸痛或心衰体征，未为了资料完整而常规加做心肌标志物及心脏超声。

报告医师：陆宁（教学模拟签署）

心电检查室 • 记录：陆宁　审核：顾川

陆宁　顾川

虚构医师手写式模拟签名 • 教学用

姓名：王建华（虚构）　男　56岁　科室：消化内科　病案号：SIM-ASC-20260901

诊断性腹腔穿刺操作记录

操作日期：2026-09-01 开始11:00，结束11:15

适应证及术前评估

肝硬化腹水加重住院，轻腹痛及肾功能异常，需判断腹水性质及排查感染。意识清楚，BP 98/62 mmHg，未见活动性出血；血小板68×10^9/L、INR1.55。结合超声安全窗及低风险操作性质，不单凭上述指标预防性输注血浆或血小板。

知情同意记录

已向患者及妻子说明目的、替代检查及出血、感染、肠管损伤、漏液等风险，患者理解并同意。此为模拟同意过程记录，无真实签名或法律效力。

操作经过

患者排空膀胱后取仰卧偏左侧位，超声选取左下腹足量游离液体区，避开腹壁血管、肠管及瘢痕。常规消毒铺巾，1%利多卡因5 mL（50 mg）逐层局麻。无菌穿刺进入腹腔，抽得淡黄色微浑浊腹水40 mL。

床旁将腹水各10 mL接种需氧、厌氧血培养瓶；余量分别送细胞计数与分类及生化。腹水采样在头孢曲松和白蛋白输注之前。拔针后局部压迫并敷无菌贴，标本标识核对后立即送检。

术后情况及医嘱

患者无明显不适，BP 100/64 mmHg、P 94次/min，穿刺点干燥，无出血或漏液。观察腹痛、腹围、脉搏、血压及局部情况。该次仅诊断取样，不属于大量放腹水，无按放液量补白蛋白指征；当日白蛋白另用于SBP相关肾损伤风险管理。

操作者：赵衡；指导者：沈妍；护士：姜悦（教学模拟签署）

消化内科 • 记录：赵衡　审核：沈妍



虚构医师手写式模拟签名 • 教学用

姓名：王建华（虚构）　男　56岁　科室：消化内科　病案号：SIM-ASC-20260901

腹水常规及生化报告单

报告号：ASC-A01 标本：腹水

采集时间：09-01 11:05 报告时间：09-01 11:45（细胞）/ 12:00（生化）

检验项目	结果	提示	单位	参考区间 / 判读界值
颜色 / 透明度	淡黄色 / 微浑浊			描述性项目
有核细胞总数	1000		个/μL	无统一正常参考区间
中性粒细胞比例	64		%	结合绝对计数
中性粒细胞绝对计数	640	↑	个/μL	<250；≥250为SBP诊断界值
红细胞	400		个/μL	结合穿刺情况
腹水白蛋白	7		g/L	结合同时血清白蛋白
腹水总蛋白	10		g/L	结合病因；<15提示低蛋白腹水
葡萄糖	5.5		mmol/L	结合血糖及临床
LDH	72		U/L	结合血清LDH上限250

检验方法：细胞计数/涂片分类及常规生化；均为模拟结果

有核细胞1000×中性粒细胞64%=640个/μL。血清白蛋白25 g/L、腹水白蛋白7 g/L，SAAG=18 g/L。PMN箭头相对临床判读界值，而非健康人的腹水参考区间。低蛋白、葡萄糖未降低及LDH未升高不能单独排除继发性腹膜炎。

检验者：林砚 审核者：苏禾（角色标识，教学模拟签署）

检验科 • 记录：林砚　审核：苏禾

林砚　苏禾

虚构医师手写式模拟签名 • 教学用

姓名：王建华（虚构）　男　56岁　科室：消化内科　病案号：SIM-ASC-20260901

当日病程及上级医师查房记录

2026-09-01 12:15

检查结果与诊断修正

腹水PMN640个/μL，SAAG18 g/L；腹水总蛋白10 g/L，血清Cr118 μmol/L、Na129 mmol/L、ALB25 g/L。初步明确门静脉高压相关腹水合并SBP。无局限性腹膜刺激征，腹水生化暂不支持继发性腹膜炎，但须观察治疗反应。

肾功能判断

08-20基线Cr78至当前118 μmol/L，增幅51%，但基线距今超过7天；当前先记“疑似AKI”，不能仅凭该旧值直接套用7日标准。患者近2天少尿，感染、摄入不足及自行加利尿剂均可能参与。次日复查及短期动态用于确认。

治疗执行

11:50开始头孢曲松2 g静脉滴注，每24小时一次。社区起病、近期无抗菌药/住院及已知耐药史；本模拟场景假定本院社区SBP经验方案允许使用该药，培养结果后复核。12:10开始20%人血白蛋白，按估计干重68 kg×1.5 g/kg=102 g（510 mL），分次缓慢输注并监测呼吸、SpO2、血压和肺部体征。

暂缓利尿剂和大量放腹水，腹胀虽明显但暂无呼吸受限或腹腔间隔室综合征证据；先控制感染和评估灌注。无休克，暂不使用血管收缩药。饮食限钠约2 g/d（折合食盐约5 g/d），保障能量及蛋白；Na129且无神经症状，不作常规严格限水。

严重程度

入院Child-Pugh按胆红素2分、白蛋白3分、INR1分、大量腹水3分、无脑病1分，共10分，C级；腹水评分属于临床判断。感染和肾功能异常增加短期风险，需密切观察。

2026-09-01 18:00：输注过程无呼吸困难或湿啰音，BP102/64 mmHg；仍腹胀，无腹膜刺激征。向家属交代夜间观察重点及病情变化可能。

消化内科 • 记录：赵衡　审核：沈妍

赵衡　沈妍

虚构医师手写式模拟签名 • 教学用

姓名：王建华（虚构）　男　56岁　科室：消化内科　病案号：SIM-ASC-20260901

住院第2日肾功能与电解质报告单

报告号：ASC-L05 标本：血清

采集时间：09-02 06:00 报告时间：09-02 07:30

检验项目	结果	提示	单位	参考区间 / 判读界值
肌酐	150	↑	μmol/L	57-97
尿素	11.8	↑	mmol/L	3.1-8
钠	128	↓	mmol/L	135-145
钾	4.8		mmol/L	3.5-5.3
氯	96	↓	mmol/L	99-110
总二氧化碳	21	↓	mmol/L	22-29
白蛋白	30	↓	g/L	40-55
总胆红素	46	↑	μmol/L	0-21
CRP	38	↑	mg/L	0-8

检验方法：模拟实验室常规方法

肌酐由前日118升至150 μmol/L，约20小时内增加32 μmol/L，满足AKI的48小时绝对升幅标准。相对可靠既往基线78为1.92倍，当前最高按1期记录。

检验者：林砚 审核者：苏禾（角色标识，教学模拟签署）

消化内科 • 记录：赵衡　审核：沈妍



虚构医师手写式模拟签名 • 教学用

姓名：王建华（虚构）　男　56岁　科室：消化内科　病案号：SIM-ASC-20260901

住院第2日病程及肾脏专科会诊

2026-09-02 09:00

病情变化

T37.1℃，BP104/66 mmHg，P90次/min；24小时尿量900 mL，体重76.1 kg。腹部仍膨隆，轻压痛较前减轻，无反跳痛。无黑便、意识改变、低氧及肺部啰音。Cr150 μmol/L，Na128 mmol/L。

AKI诊断

前日Cr118至今150，48小时内增加32 μmol/L；以08-20已知稳定78 μmol/L作分期基线，峰值为1.92倍，AKI1期。单凭每日尿量900 mL不能证明连续6小时符合少尿标准，本例诊断依据为肌酐。

会诊意见（10:30）

考虑感染诱发并伴有效循环容量不足的AKI，近期进食少和自增利尿剂可能促成。尿沉渣无显著活动性改变，蛋白尿少，超声无梗阻；目前缺乏支持肾小球肾炎或明显肾小管坏死的证据，但无法仅凭这些完全排除。HRS-AKI为需追踪的鉴别诊断，尚不能由“肝硬化+AKI”直接确诊。

处理及再评估

继续暂停利尿，继续抗菌治疗，严密记录出入量。结合末梢灌注、血压、肺部与床旁容量评估决定是否进一步补液；既已完成SBP首日白蛋白且无休克，不机械追加固定48小时扩容。无明确HRS-AKI，不启动特利加压素。24小时内复查肾功能、电解质，恶化时提前复查。

16:00腹水培养初步提示革兰阴性杆菌，药敏未回；血培养暂未检出。继续当前方案并观察。

抗病毒用药核对

峰值肌酐150 μmol/L时，按估计干重粗估CrCl约47 mL/min。恩替卡韦临时调整为1 mg每48小时：09-01已服，09-02暂停一次，次日复核肾功能。

会诊：陈谨；记录：赵衡（教学模拟签署）

消化内科 • 记录：赵衡　审核：沈妍



虚构医师手写式模拟签名 • 教学用

姓名：王建华（虚构）　男　56岁　科室：消化内科　病案号：SIM-ASC-20260901

腹水细菌培养与药敏报告单

报告号：ASC-M01 标本：腹水床旁接种需氧/厌氧培养瓶

采集时间：09-01 11:05 报告时间：09-03 09:30（终报）

检验项目	结果	提示	单位	参考区间 / 判读界值
培养结果	大肠埃希菌			阳性；单一菌种
头孢曲松	敏感（S）			模拟药敏分类
哌拉西林/他唑巴坦	敏感（S）			模拟药敏分类
美罗培南	敏感（S）			模拟药敏分类
环丙沙星	敏感（S）			模拟药敏分类
复方磺胺甲噁唑	敏感（S）			模拟药敏分类
氨苄西林	耐药（R）			模拟药敏分类
ESBL筛查	阴性			阴性

检验方法：模拟实验室常规方法

09-02 16:00初报革兰阴性杆菌；09-03鉴定及药敏终报。S/R为虚构病例的预设分类，未虚构仪器MIC或实验室断点版本。采样在首剂抗菌药之前。

检验者：林砚 审核者：苏禾（角色标识，教学模拟签署）

检验科 • 记录：林砚　审核：苏禾

林砚　苏禾

虚构医师手写式模拟签名 • 教学用

姓名：王建华（虚构）　男　56岁　科室：消化内科　病案号：SIM-ASC-20260901

住院第3日复查检验报告单

报告号：ASC-L06 标本：血清 / EDTA全血 / 腹水

采集时间：09-03 06:00（血）/ 11:50（腹水）　报告时间：09-03 07:30 / 12:30

检验项目	结果	提示	单位	参考区间 / 判读界值
白细胞	5.6		10^9/L	3.5-9.5
血红蛋白	116	↓	g/L	130-175
血小板	70	↓	10^9/L	125-350
肌酐	112	↑	μmol/L	57-97
尿素	9.5	↑	mmol/L	3.1-8
钠	130	↓	mmol/L	135-145
钾	4.5		mmol/L	3.5-5.3
CRP	20	↑	mg/L	0-8
腹水有核细胞总数	300		个/μL	无统一参考区间
腹水中性粒细胞比例	40		%	结合绝对计数
腹水PMN绝对计数	120		个/μL	<250；≥250为SBP诊断界值

检验方法：模拟实验室常规方法

复查穿刺距首剂头孢曲松约48小时；PMN由640降至120个/μL，下降81.25%。血标本于第3日白蛋白输注前采集。

检验者：林砚　审核者：苏禾（角色标识，教学模拟签署）

检验科 • 记录：林砚　审核：苏禾

林砚　苏禾

虚构医师手写式模拟签名 • 教学用

姓名：王建华（虚构）　男　56岁　科室：消化内科　病案号：SIM-ASC-20260901

住院第3日病程及复查穿刺记录

2026-09-03 09:00 / 11:45-12:00 / 14:00

查房情况

无发热，BP106/66 mmHg，P84次/min，尿量1300 mL/24h，体重75.8 kg。腹痛消失，腹胀仍较明显；无腹膜刺激征、脑病及呼吸困难。Cr从150降至112 μmol/L，Na130 mmol/L。

复查穿刺

因本例曾发生肾功能恶化，拟复查治疗反应。再次说明并获得模拟知情同意；超声选择左下腹安全窗，无菌操作，1%利多卡因3 mL局麻，抽取腹水20 mL送细胞分类及培养，拔针压迫敷贴。术前后血压稳定，无出血、漏液及明显腹痛。操作者赵衡，指导者沈妍。

结果解释

PMN120个/μL，较640下降81.25%，低于250；培养为头孢曲松敏感大肠埃希菌，症状与肾功能同步改善，支持当前抗菌方案有效。无证据要求升级碳青霉烯；无继发性腹膜炎临床新线索，暂不行增强CT。若反应不佳则重新检查病因与感染源。

治疗

继续头孢曲松2 g每日一次，预计总疗程7天（09-01至09-07）。按SBP方案第3日20%白蛋白68 g（340 mL），分次监测输注。继续暂缓利尿，次日复查肾功能，如灌注稳定可考虑治疗性放腹水缓解症状。

不因肾功能短期改善就宣布所有肾病已排除；但当前恢复轨迹不支持把HRS-AKI写成已确诊的出院诊断。

肌酐112 μmol/L时粗估CrCl约63 mL/min，恩替卡韦恢复1 mg每日一次空腹口服。

消化内科 • 记录：赵衡　审核：沈妍

赵衡　沈妍

虚构医师手写式模拟签名 • 教学用

姓名：王建华（虚构）　男　56岁　科室：消化内科　病案号：SIM-ASC-20260901

放腹水前安全评估检验单

报告号：ASC-L07 标本：血清 / 枸橼酸血浆 / EDTA全血

采集时间：09-04 06:00 报告时间：09-04 07:30

检验项目	结果	提示	单位	参考区间 / 判读界值
肌酐	96		μmol/L	57-97
尿素	7.6		mmol/L	3.1-8
钠	132	↓	mmol/L	135-145
钾	4.3		mmol/L	3.5-5.3
白蛋白	32	↓	g/L	40-55
总胆红素	38	↑	μmol/L	0-21
INR	1.45	↑		0.8-1.2
血小板	72	↓	10^9/L	125-350

检验方法：模拟实验室常规方法

结合查体无出血、血流动力学稳定及超声安全窗，决定行治疗性放腹水。白蛋白水平受前期输注影响，不作为肝合成功能短期恢复的单独证明。

检验者：林砚 审核者：苏禾（角色标识，教学模拟签署）

检验科 • 记录：林砚　审核：苏禾



虚构医师手写式模拟签名 • 教学用

姓名：王建华（虚构）　男　56岁　科室：消化内科　病案号：SIM-ASC-20260901

治疗性腹腔穿刺放液记录

2026-09-04 开始10:00，结束11:40

操作前诊断及适应证

肝硬化大量腹水；SBP治疗反应良好，肾功能恢复。仍明显腹胀早饱，腹壁紧张。BP108/68 mmHg，P82次/min，SpO2 98%。当前未符合难治性腹水定义。

知情同意与准备

说明放液目的、白蛋白补充及出血、感染、低血压、循环功能障碍、漏液等风险，患者同意。核对身份和超声窗，排空膀胱；无预防性血浆/血小板输注。

操作经过

取半卧位，超声选左下腹安全液体区，避开腹壁血管。常规无菌消毒铺巾，1%利多卡因5 mL局麻后置入一次性腹腔穿刺导管，分段观察下缓慢放出淡黄色清亮腹水共6000 mL。期间每15分钟观察生命体征和症状。未留置持续引流管，操作完成拔管、压迫并敷无菌贴。

白蛋白与安全记录

按放液量6 L×8 g/L，另予20%人血白蛋白48 g（240 mL）于操作结束后缓慢静滴并监测。此为放腹水适应证，与09-01、09-03的SBP方案分别记录，非同日重复计算。

术后

末次BP106/66 mmHg，P80次/min，SpO2 98%；腹胀明显缓解，腹围由105 cm降至96 cm，体重由75.6 kg降至69.6 kg。局部无渗血漏液，无腹痛加重及晕厥。继续观察2小时，次晨复查肾功能和电解质。

操作医师赵衡；指导医师沈妍；护士姜悦（均为模拟角色）。本例未行外科手术，本记录为有创操作记录。

消化内科 • 记录：赵衡　审核：沈妍

赵衡　沈妍

虚构医师手写式模拟签名 • 教学用

姓名：王建华（虚构）　男　56岁　科室：消化内科　病案号：SIM-ASC-20260901

住院第4至6日病程记录

09-04 17:00 · 放腹水后查房

患者可较舒适进食和平卧，BP108/68 mmHg，穿刺点干燥，无发热及腹痛。无肺水肿表现。记录放液6000 mL为操作排液，不将当日6 kg体重下降解释为利尿效果。继续监测，暂不追加利尿剂。

09-05 09:00 · 恢复低剂量利尿

T36.7℃，BP110/68 mmHg，体重69.4 kg，尿量1400 mL/24h。Cr88 μmol/L、Na133、K4.2 mmol/L。腹水少量残留，踝部轻度水肿。恢复螺内酯50 mg每日一次、呋塞米20 mg每日一次，均口服；因近期AKI从低剂量开始，当前不需要追求最大剂量。每日同条件称重，观察血压、尿量及肌酐和电解质。

09-06 09:00 · 疗效与营养

T36.6℃，BP110/70 mmHg，体重69.0 kg，尿量1800 mL/24h；轻踝部水肿，腹痛无再发，正常排便。体重较前日下降0.4 kg，耐受良好。血培养5天终报未检出细菌；09-03腹水复培养尚未终报，不误写为已阴性。

营养和活动计划

按估计干重68 kg安排约2040-2380 kcal/d，蛋白约82-102 g/d，少量多餐及睡前加餐。既有水肿又有肌肉减少体征，不能用含腹水体重直接判断营养充分。无需常规限蛋白；在耐受范围内步行和轻量抗阻活动。

饮食、体重和药量由医护共同核对。低钠饮食不等于完全无盐；无严重低钠及神经症状，不常规严格限水。

消化内科 • 记录：赵衡　审核：沈妍

赵衡　沈妍

虚构医师手写式模拟签名 • 教学用

姓名：王建华（虚构）　男　56岁　科室：消化内科　病案号：SIM-ASC-20260901

治疗后肾功能及出院前检验单

报告号：ASC-L08 标本：血清 / EDTA全血 / 枸橼酸血浆

采集时间：09-05 / 09-07 / 09-09 06:00 报告时间：对应日期07:30

检验项目	结果	提示	单位	参考区间 / 判读界值
09-05 肌酐	88		μmol/L	57-97
09-05 钠	133	↓	mmol/L	135-145
09-05 钾	4.2		mmol/L	3.5-5.3
09-07 肌酐	84		μmol/L	57-97
09-07 钠	134	↓	mmol/L	135-145
09-07 钾	4.1		mmol/L	3.5-5.3
09-07 CRP	5		mg/L	0-8
09-09 肌酐	82		μmol/L	57-97
09-09 尿素	5.6		mmol/L	3.1-8
09-09 钠	134	↓	mmol/L	135-145
09-09 钾	4.2		mmol/L	3.5-5.3
09-09 白蛋白	32	↓	g/L	40-55
09-09 总胆红素	30	↑	μmol/L	0-21
09-09 INR	1.35	↑		0.8-1.2
09-09 白细胞	4.2		10^9/L	3.5-9.5
09-09 血红蛋白	119	↓	g/L	130-175
09-09 血小板	75	↓	10^9/L	125-350

检验方法：模拟实验室常规方法

这是模拟LIS多时点归并打印单，每个项目保留采集日期；并非同次采血。Na134仍低于本实验室下限，出院诊断写“改善”，不写“完全正常”。

检验者：林砚　审核者：苏禾（角色标识，教学模拟签署）

检验科 • 记录：林砚　审核：苏禾

林砚　苏禾

虚构医师手写式模拟签名 • 教学用

姓名：王建华（虚构）　男　56岁　科室：消化内科　病案号：SIM-ASC-20260901

微生物培养终报

报告号 / 时间	标本 / 结果
ASC-M02 / 09-06 10:00	09-01 09:50采集两组外周血培养；培养5天未检出细菌。
ASC-M03 / 09-08 12:30	09-03 11:50采集复查腹水培养；培养5天未检出细菌。

微生物结果均为病例合成；培养阴性不能在缺乏细胞计数及临床评估时单独证明感染排除。

检验科 • 记录：林砚　审核：苏禾

林砚　苏禾

虚构医师手写式模拟签名 • 教学用

姓名：王建华（虚构）　男　56岁　科室：消化内科　病案号：SIM-ASC-20260901

出院前超声检查报告单

ASC-US02 · 09-08 09:30复查超声报告

肝脾形态与前相仿，腹盆腔少量游离液体，较前明显减少；未见新发明确肝内占位或门静脉主干血栓。双肾集合系统无扩张。

检查目的：评估残余腹水及肾脏情况。复查仅提供文字报告，不复用入院大量腹水示意图冒充复查图像。

超声科 · 记录：许澄　审核：周岚



虚构医师手写式模拟签名 · 教学用

姓名：王建华（虚构）　男　56岁　科室：消化内科　病案号：SIM-ASC-20260901

住院第7至8日病程记录

09-07 09:00病程

体重68.6 kg，BP112/70 mmHg，尿量1700 mL/24h，腹痛和水肿消失。Cr84，Na134，K4.1，CRP5。完成第7天头孢曲松后停药。既往无SBP，本次确诊并恢复，评估启动二级预防。

09-08 09:00病程

体重68.3 kg，BP110/68 mmHg，尿量1500 mL/24h；进食睡眠改善。综合药敏、肾功能、药物相互作用及不良反应风险，开始环丙沙星500 mg口服每日一次用于SBP二级预防；告知肌腱疼痛、周围神经症状及严重腹泻等需及时联系医生。该方案须随耐药谱及耐受性复评。

随访安排

预约09-12复查肾功能及电解质；09-16肝病/肝移植评估门诊，讨论失代偿后的长期策略。未将TIPS或肝移植写成本次已完成治疗。

消化内科 • 记录：赵衡　审核：沈妍



虚构医师手写式模拟签名 • 教学用

姓名：王建华（虚构）　男　56岁　科室：消化内科　病案号：SIM-ASC-20260901

医嘱与执行摘要

药品	剂量 / 途径 / 频次	时间	用途与核对
头孢曲松	2 g / 静脉滴注 / 每24小时	09-01 11:50至09-07，共7次	SBP治疗；培养敏感后继续，09-07完成后停止
20%人血白蛋白	102 g=510 mL / 静滴 / 一次疗程分次	09-01	SBP第1日，估计干重68×1.5；监测输注耐受
20%人血白蛋白	68 g=340 mL / 静滴 / 一次疗程分次	09-03	SBP第3日，68×1；不是按血清白蛋白补至正常
20%人血白蛋白	48 g=240 mL / 静滴	09-04放液后	放腹水6 L×8 g/L；与SBP方案分日记录
螺内酯	50 mg / 口服 / 每日一次	09-01至04暂停；09-05恢复	监测血钾、肌酐、血压；本例低剂量重启
呋塞米	20 mg / 口服 / 每日一次	09-01至04暂停；09-05恢复	与螺内酯合用；不自行加量
恩替卡韦	1 mg / 口服 / 每日一次空腹	09-01服用；09-02暂停一次；09-03恢复	AKI峰值临时改每48小时；恢复后1 mg/d，出院继续
环丙沙星	500 mg / 口服 / 每日一次	09-08起，09-16复评	SBP二级预防；非延长急性感染静脉疗程
1%利多卡因	5/3/5 mL / 局部浸润 / 各一次	09-01 / 03 / 04操作时	分别50/30/50 mg；无其他同日局麻药

此为该患者实际用药的合成执行摘要，不是扩展HIS药品目录。每次静脉药物的稀释、输注速率及制剂规格须依据本地说明书和药学审核，不伪造批号。

恩替卡韦峰值肌酐150 μmol/L时，以56岁男性、估计干重68 kg作Cockcroft-Gault粗估约47 mL/min，但AKI时估算不稳定；当日由临床药师评估临时改为1 mg每48小时（09-02暂停一次），09-03肌酐112后恢复1 mg/d。详见下页核对说明。

消化内科 • 记录：赵衡　审核：沈妍

赵衡　沈妍

虚构医师手写式模拟签名 • 教学用

姓名：王建华（虚构）　男　56岁　科室：消化内科　病案号：SIM-ASC-20260901

药学核对与非药物医嘱

恩替卡韦调量明细

既往长期1 mg/d。本次09-01已服1 mg；09-02肌酐峰值150时粗估CrCl约47 mL/min，按说明书30-49 mL/min失代偿剂量可用1 mg每48小时，因此09-02不服；09-03肌酐112，粗估约63 mL/min，恢复1 mg/d。AKI时CrCl估计有局限，需动态复评；本例无透析。空腹指餐前或餐后至少2小时。

抗菌药核对

头孢曲松为病例设定的社区起病经验方案，药敏支持。不得将本例药敏推广为当地真实耐药率。环丙沙星用于SBP二级预防，需评估耐药、QT、肌腱/神经不良反应及艰难梭菌风险；与钙、铁、镁等多价阳离子制剂错开服用。肾功能恶化时重新核对剂量。

利尿安全

开始时与每次剂量调整后检查血压、体重、尿量、肌酐、Na/K。无外周水肿时每日体重下降一般不超过0.5 kg，有水肿时一般不超过1 kg；本例以更缓慢下降为目标。09-04因放液下降6 kg单独记录。若头晕、少尿、肌酐上升、显著低钠或高低钾，及时暂停/调整并查因。

非药物医嘱

消化内科护理，入院早期每4小时生命体征；白蛋白输注及操作期加密监测。每日晨起排尿后同秤称重，定点测腹围，记录出入量。限钠约2 g/d，保障营养；饮水依血钠和容量状态个体化。鼓励耐受范围内活动，防跌倒。

本例未使用的治疗

无肝性脑病，不常规给予乳果糖/利福昔明；无消化道出血，不予止血药或经验性PPI；无HRS-AKI确诊，不使用特利加压素；无明显腹水难治性证据，不安排TIPS。既往小静脉曲张的预防策略待循环稳定后专科复评。

消化内科 • 记录：赵衡　审核：沈妍

赵衡　沈妍

虚构医师手写式模拟签名 • 教学用

姓名：王建华（虚构）　男　56岁　科室：消化内科　病案号：SIM-ASC-20260901

护理记录与病情趋势

日期	体重kg	腹围cm	BP mmHg	尿量mL	关键事项
09-01	76.0	106	98/62	900	诊断穿刺40 mL；白蛋白102 g
09-02	76.1	106	104/66	900	AKI确认；继续停利尿
09-03	75.8	105	106/66	1300	复查穿刺20 mL；白蛋白68 g
09-04	75.6→69.6	105→96	108/68	1400	放液6000 mL；白蛋白48 g
09-05	69.4	96	110/68	1400	恢复低剂量双利尿
09-06	69.0	95	110/70	1800	耐受良好
09-07	68.6	95	112/70	1700	完成7天静脉抗菌
09-08	68.3	94	110/68	1500	开始SBP二级预防
09-09	68.1	94	112/70	1500	出院

尿量按当日查房前最近24小时统计；09-01为患者自述估计量，之后为病房记录。09-04体重和腹围注明操作前后值。未留置导尿管，使用专用量杯记录。

护理观察

患者住院期间神志清，无呕血黑便及跌倒；各穿刺点保持干燥，无持续漏液或明显血肿。白蛋白输注期间无急性呼吸困难、低氧及湿啰音。

健康教育与复述

患者能复述“利尿药不能自行加量；每日同条件称重；出现尿量明显减少、发热腹痛、黑便或意识变化要及时就医”。妻子参与药物整理与饮食计划。

护理记录者：姜悦；查对者：宋青（教学模拟签署）

消化内科护理组 • 记录：姜悦　审核：宋青



虚构医师手写式模拟签名 • 教学用

姓名：王建华（虚构）　男　56岁　科室：消化内科　病案号：SIM-ASC-20260901

出院记录

出院日期：2026-09-09 10:00

入院情况

因反复腹胀6个月、加重10天伴尿量减少2天入院。入院体重76 kg、大量腹水、双下肢水肿，BP98/62 mmHg。腹水PMN640个/μL、SAAG18 g/L，随后培养大肠埃希菌。

诊疗经过

及时完成腹腔穿刺，给予头孢曲松7天及SBP方案白蛋白。第2日Cr由118升至150 μmol/L，确认AKI1期，暂停利尿、评估灌注及肾损伤病因，并短暂调整恩替卡韦给药间隔。第3日腹水PMN下降至120，Cr112。第4日Cr96后行治疗性放腹水6 L并补白蛋白48 g；第5日起恢复低剂量螺内酯/呋塞米，肾功能稳定。第8日起SBP二级预防。

出院诊断

1.乙肝肝硬化失代偿期伴腹水。2.自发性细菌性腹膜炎（大肠埃希菌，已控制）。3.急性肾损伤1期（已恢复，感染及有效循环容量不足相关）。4.低钠血症（改善）。5.门静脉高压，脾大伴血小板减少。6.低白蛋白血症。

出院情况

体温36.6℃，P78次/min，BP112/70 mmHg，神志清，饮食改善，无腹痛，少量残余腹水，无明显外周水肿。体重68.1 kg；Cr82 μmol/L、Na134、K4.2 mmol/L，ALB32 g/L、TBil30 μmol/L、INR1.35。肌酐距既往基线仅增加4 μmol/L，符合恢复轨迹。

严重程度与转归

出院Child-Pugh按胆红素1、白蛋白2、INR1、利尿可控少量腹水2、无脑病1，共7分，B级；近期白蛋白输注影响评分解释。临床好转不等于肝硬化治愈。无证据确诊HRS-AKI或难治性腹水。

出院医嘱及随访见下一页。记录医师赵衡；上级医师沈妍（教学模拟签署）。

消化内科 • 记录：赵衡　审核：沈妍

赵衡　沈妍

虚构医师手写式模拟签名 • 教学用

姓名：王建华（虚构）　男　56岁　科室：消化内科　病案号：SIM-ASC-20260901

出院带药及随访计划

药物	用法	目的 / 复核
恩替卡韦	1 mg口服，每日一次，空腹	持续抗病毒，不自行停药；监测肾功能与HBV DNA
螺内酯	50 mg口服，每日一次	控制腹水；监测肌酐、血钾、血钠、血压
呋塞米	20 mg口服，每日一次	控制腹水；不自行加量
环丙沙星	500 mg口服，每日一次；先开至09-16复诊	SBP二级预防，复诊决定续方；不可理解为仅需预防7天

近期复查

09-12（出院后3天）：血压、体重、肾功能、Na/K，核对利尿药耐受性；如异常提前就诊。09-16：肝病专科和肝移植评估门诊，复查血常规、肝功能及凝血，评估腹水、营养及二级预防药物。

长期管理

维持低钠饮食与足量能量、蛋白，少量多餐及睡前加餐，戒酒。每日称重并记录；避免自行使用NSAIDs及来历不明中草药。规律抗病毒随访，按专科计划监测HBV DNA；肝癌监测一般每6个月超声联合AFP，下次计划2027-03，异常时提前进一步检查。既往静脉曲张及NSBB耐受性于近期专科复评。

需要及时就医

发热或新发腹痛、尿量明显减少、持续头晕/晕厥、呕血黑便、嗜睡或行为异常、呼吸困难应立即就医；腹围及体重连续上升、食欲再次下降应尽早联系随访医生。出现肌腱痛、麻木或严重腹泻须及时复核环丙沙星。

患者理解确认

患者和妻子能够复述药物名称、不能自行增加利尿剂及复查日期。已解释病情仍需长期管理，肝移植评估不是已经确定接受移植。

消化内科 • 记录：赵衡　审核：沈妍

赵衡　沈妍

虚构医师手写式模拟签名 • 教学用